



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN
DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
TRIWULAN I**

TAHUN 2026

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Insiden Keselamatan Bulan Januari hingga Maret tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sehingga dapat dilaporkan kepada Pemilik Rumah Sakit Prima Husada Malang. Seperti yang kita pahami bahwa nafas dari *Patient Safety* adalah belajar (*learning*) dari KTD yang terjadi untuk selanjutnya disusun langkah-langkah agar kejadian serupa tidak akan terulang Kembali, baik di tempat/unit yang sama maupun di tempat/unit yang lain di Rumah Sakit Prima Husada, sehingga dapat meningkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien.

Salah satu program utama dalam penerapan Keselamatan Pasien adalah pelaporan Insiden Keselamatan Pasien. Pelaporan ini akan menggerakkan berbagai proses lanjutan seperti analisis terhadap Insiden dan akibat-akibatnya, penemuan berbagai penyebab, solusinya, dan implementasi. Pelaporan insiden dan proses-proses lanjutan tersebut merupakan jawaban yang paling tepat terhadap keberadaan KTD / KNC / KTC / KPCS, sehingga diharapkan statistic KTD / KNC ini dapat ditekan, dan lebih utama lagi terlaksananya asuhan pasien yang lebih aman.

Dengan tersusunya Laporan Insiden Keselamatan Pasien ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistematis dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... 1

Daftar Isi 2

Bab I Pendahuluan 3

 1.1 Latar Belakang..... 3

 1.2 Tujuan..... 3

Bab II Pelaporan Insiden 2

 2.1 Data Insiden Keselamatan Pasien RS Prima Husada Periode Bulan Januari-Maret Tahun 2026..... 2

 2.2 Pengumpulan Data Insiden..... **Error! Bookmark not defined.**

 2.3 Grafik Insiden Keselamatan Pasien TW I Tahun 2026 RS Prima Husada Malang ... 5

Bab III Penutup..... 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi Rumah Sakit Prima Husada adalah menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan visi Rumah Sakit Prima Husada tersebut, maka didukung oleh 3 misi sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat, akurat. 2) Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien. 3) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan. Dalam upaya memberikan pelayanan berkualitas prima yang mengedepankan peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan Standar Akreditasi RS Kemenkes (STARKES). Kegiatan ini dilakukan di setiap unit terkait untuk mengukur kinerja pelayanan rumah sakit dan sebagai manajemen kontrol untuk mendukung pengambilan keputusan.

Salah satu program utama dalam penerapan Keselamatan Pasien adalah pelaporan Insiden Keselamatan Pasien. Pelaporan ini akan menggerakkan berbagai proses lanjutan seperti analisis terhadap Insiden dan akibat-akibatnya, penemuan berbagai penyebab, solusinya, dan implementasi. Pelaporan insiden dan proses-proses lanjutan tersebut merupakan jawaban yang paling tepat terhadap keberadaan KTD / KNC / KTC / KPCS, sehingga diharapkan statistik KTD / KNC ini dapat ditekan, dan lebih utama lagi terlaksananya asuhan pasien yang lebih aman.

Laporan Insiden Keselamatan pasien ini dibuat agar kejadian serupa tidak akan terulang Kembali, baik di tempat/unit yang sama maupun di tempat/unit yang lain di Rumah Sakit Prima Husada, sehingga dapat meningkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien.

1.2 Tujuan

Tujuan Umum

- a. Menurunnya Insiden Keselamatan pasien (KTD, KNC, KTC, dan KPC)
- b. Meningkatkan mutu pelayanan dan Keselamatan pasien

Tujuan Khusus

- a. Terlaksananya sistem pelaporan dan pencatatan insiden keselamatan pasien rumah sakit.
- b. Diketahui penyebab Insiden keselamatan pasien sampai pada akar masalah.
- c. Didapatkan pembelajaran untuk perbaikan asuhan kepada pasien agar dapat mencegah kejadian yang sama dikemudian hari.

BAB II
PELAPORAN INSIDEN

2.1 PENGUMPULAN DATA INSIDEN BERDASARKAN KATEGORI PMKP 9

No	Kategori	Insiden	Jumlah
1.	Semua reaksi transfusi yang sudah dikonfirmasi	Tidak ada insiden	0
2.	Semua kejadian serius akibat reaksi obat (<i>adverse drug reaction</i>) yang serius sesuai yang ditetapkan oleh rumah sakit	Tidak ada insiden	0
3.	Semua kesalahan pengobatan (<i>medication error</i>) yang signifikan sesuai yang ditetapkan oleh rumah sakit	Kesalahan pemberian obat Kesalahan input e-resep	10
4.	Semua perbedaan besar antara diagnosis pra dan diagnosis pascaoperasi; misalnya diagnosis praoperasi adalah obstruksi saluran pencernaan dan diagnosis pascaoperasi adalah ruptur aneurisme aorta abdominalis (AAA)	Tidak ada insiden	0
5.	Kejadian tidak diharapkan atau pola kejadian tidak diharapkan selama sedasi procedural tanpa memandang cara pemberian	Tidak ada insiden	0
6.	Kejadian tidak diharapkan atau pola kejadian tidak diharapkan selama sedasi tanpa memandang cara pemberian	Tidak ada insiden	0
7.	Kejadian tidak diharapkan yang berkaitan dengan identifikasi pasien	Tidak ada insiden	0
8.	Kejadian – kejadian lain, misalnya infeksi yang berkaitan dengan perawatan kesehatan atau wabah penyakit menular	Tidak ada insiden	0
Total			10

Analisis:

- Berdasarkan data indikator klinis area sasaran keselamatan pasien, selama periode pelaporan terdapat 10 insiden yang seluruhnya berasal dari kategori kesalahan pengobatan (*medication error*).
- Insiden *medication error* yang terjadi meliputi kesalahan pemberian obat dan kesalahan input e-resep, yang menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian dalam proses peresepan, verifikasi, maupun pemberian obat kepada pasien.
- Tidak ditemukan insiden pada kategori lain, seperti reaksi transfusi yang terkonfirmasi, kejadian serius akibat reaksi obat, perbedaan diagnosis pra dan pascaoperasi, kejadian terkait sedasi, kesalahan identifikasi pasien, maupun infeksi terkait pelayanan kesehatan.
- Tidak adanya insiden pada kategori-kategori tersebut menunjukkan bahwa proses pelayanan yang berkaitan dengan transfusi, tindakan operasi, sedasi, identifikasi pasien, dan pencegahan infeksi telah berjalan dengan baik sesuai standar yang ditetapkan rumah sakit.
- *Medication error* menjadi kategori insiden yang paling dominan dan perlu menjadi fokus perbaikan karena berpotensi memengaruhi keselamatan pasien apabila tidak segera diidentifikasi dan ditangani.

- Kejadian kesalahan input e-resep mengindikasikan perlunya peningkatan ketelitian petugas dalam proses entri resep elektronik serta optimalisasi sistem verifikasi sebelum obat disiapkan dan diberikan kepada pasien.
- Secara keseluruhan, meskipun jumlah insiden relatif rendah dan tidak ditemukan kejadian dengan dampak yang lebih serius, upaya pencegahan medication error tetap perlu ditingkatkan untuk mendukung terciptanya pelayanan yang aman dan bermutu.

2.2 DATA KETIDAKSESUAIAN DIAGNOSIS PRA OPERASI DAN PASCA OPERASI BULAN JANUARI-MARET TAHUN 2026

No	Bulan	Jumlah Operasi		Jumlah Ketidaksesuaian
		Elektif	Cito	
1	Januari	349	24	0
2	Februari	311	50	0
3	Maret	269	56	0

Kesimpulan:
Tidak ada kejadian ketidaksesuaian diagnosis pra operasi dan pasca operasi yang terjadi pada Bulan Januari sampai Maret 2026.

- Analisis:**
- Selama Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan 1.059 tindakan operasi, terdiri dari 929 operasi elektif dan 130 operasi cito.
 - Jumlah operasi tertinggi terjadi pada bulan Januari sebanyak 373 tindakan, sedangkan terendah pada bulan Maret sebanyak 325 tindakan.
 - Tidak ditemukan ketidaksesuaian antara diagnosis praoperasi dan pascaoperasi pada seluruh tindakan operasi yang dilakukan selama periode Januari–Maret 2026.
 - Capaian ini menunjukkan bahwa proses penegakan diagnosis sebelum operasi telah dilakukan dengan baik melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, serta evaluasi klinis yang adekuat.
 - Tidak adanya ketidaksesuaian diagnosis mencerminkan ketepatan pengambilan keputusan klinis dan koordinasi yang baik antara dokter operator, DPJP, dan unit penunjang.
 - Hasil ini menunjukkan mutu pelayanan bedah yang baik serta mendukung keselamatan pasien dalam proses pelayanan operatif.
 - Meskipun capaian telah mencapai 100%, monitoring dan evaluasi tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai.

- Rencana Tindak Lanjut:**
- Mempertahankan pelaksanaan asesmen praoperasi secara komprehensif sesuai standar dan pedoman yang berlaku.
 - Memastikan pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai indikasi klinis untuk mendukung ketepatan diagnosis sebelum operasi.
 - Melaksanakan audit rekam medis dan evaluasi kesesuaian diagnosis praoperasi dan pascaoperasi secara berkala.
 - Mempertahankan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara dokter operator, dokter penanggung jawab pasien, dan unit penunjang.
 - Melakukan pembahasan kasus dan kegiatan ilmiah secara berkala untuk mempertahankan kompetensi tenaga medis dalam penegakan diagnosis dan perencanaan tindakan operasi.
 - Melakukan monitoring indikator secara rutin sebagai upaya menjaga mutu pelayanan bedah dan keselamatan pasien.

2.3 DATA KEJADIAN REAKSI TRANSFUSI

No	Bulan	Jumlah Kejadian Reaksi Transfusi	Jumlah Transfusi
1	Januari	0	91
2	Februari	0	96
3	Maret	0	74

Kesimpulan:
Tidak ada kejadian reaksi transfusi yang terjadi pada Bulan Januari sampai Maret 2026.

Analisis:

- Tidak terdapat kejadian reaksi transfusi selama periode Januari hingga Maret 2026.
- Hasil ini menunjukkan bahwa proses pelayanan transfusi darah telah dilaksanakan sesuai standar, mulai dari seleksi donor, pemeriksaan kompatibilitas darah, verifikasi identitas pasien, hingga pemantauan selama transfusi.
- Tidak adanya kejadian reaksi transfusi mencerminkan upaya pencegahan dan pengawasan yang baik oleh tenaga kesehatan dalam pelaksanaan transfusi darah.
- Meskipun tidak ditemukan kejadian reaksi transfusi, kewaspadaan tetap perlu dipertahankan karena risiko reaksi transfusi dapat terjadi sewaktu-waktu.

Rencana Tindak Lanjut:

- Mempertahankan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan transfusi darah yang berlaku.
- Melakukan monitoring pasien secara ketat sebelum, selama, dan setelah transfusi untuk mendeteksi kemungkinan reaksi transfusi secara dini.
- Melaksanakan edukasi dan sosialisasi berkala kepada tenaga kesehatan terkait identifikasi, penanganan, dan pelaporan reaksi transfusi.
- Melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan prosedur transfusi dan dokumentasinya.
- Memastikan seluruh kejadian yang dicurigai sebagai reaksi transfusi, termasuk reaksi ringan, tetap dilaporkan dan didokumentasikan sesuai ketentuan.

2.4 DATA KEJADIAN INFEKSI

NO	HAIs	Bulan		
		Jan '26	Feb '26	Mar '26
1	IDO (Infeksi Daerah Operasi)	0%	0%	0%
2	VAP (Ventilation Associated Pneumonia)	0 ‰	0 ‰	1.82%
3	ISK (Infeksi Saluran Kencing)	0 ‰	0 ‰	0.81%
4	Infeksi Aliran Darah Perifer /ILI (Phlebitis)	0.35%	0.3%	0.17%

Analisis:

- a) Pada periode Januari–Maret 2026 tidak ditemukan kasus Infeksi Daerah Operasi (IDO), menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap penerapan bundle pencegahan infeksi pada pasien bedah.
- b) Tidak terdapat kasus Ventilator Associated Pneumonia (VAP) pada bulan Januari dan Februari, namun pada bulan Maret terjadi peningkatan menjadi 1,82‰, yang menunjukkan adanya kejadian infeksi terkait penggunaan ventilator dan memerlukan evaluasi lebih lanjut.
- c) Tidak ditemukan kasus Infeksi Saluran Kemih (ISK) pada bulan Januari dan Februari, namun pada bulan Maret tercatat 0,81‰, yang mengindikasikan adanya infeksi terkait pemasangan kateter urin yang perlu dilakukan investigasi penyebabnya.
- d) Angka Infeksi Aliran Darah Perifer/Phlebitis (ILI) menunjukkan tren menurun dari 0,35% pada Januari, 0,30% pada Februari, menjadi 0,17% pada Maret. Hasil ini menunjukkan adanya perbaikan dalam praktik pemasangan dan perawatan akses intravena.
- e) Secara keseluruhan, capaian IDO dan phlebitis cukup baik, namun munculnya kasus VAP dan ISK pada bulan Maret memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi peningkatan pada periode berikutnya.

Rencana Tindak Lanjut:

- a) Melakukan investigasi dan analisis kasus terhadap kejadian VAP dan ISK yang terjadi pada bulan Maret untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan faktor risiko.
- b) Meningkatkan kepatuhan terhadap bundle pencegahan VAP, termasuk elevasi kepala tempat tidur, oral hygiene, penilaian harian kebutuhan ventilator, dan penerapan teknik

-
- aseptik dalam pengelolaan ventilator.
- c) Meningkatkan kepatuhan terhadap bundle pencegahan ISK, termasuk evaluasi harian kebutuhan kateter urin, teknik pemasangan aseptik, dan perawatan kateter sesuai standar.
 - d) Mempertahankan kepatuhan terhadap bundle pencegahan IDO sehingga angka kejadian tetap 0%.
 - e) Mempertahankan dan meningkatkan monitoring pemasangan serta perawatan akses intravena untuk menjaga tren penurunan angka phlebitis.
 - f) Melaksanakan audit kepatuhan PPI dan surveilans HAIs secara berkala serta memberikan umpan balik kepada unit terkait.
 - g) Melakukan edukasi dan refresh training kepada tenaga kesehatan mengenai pencegahan HAIs, khususnya terkait VAP, ISK, dan phlebitis.
 - h) Memantau tren kejadian HAIs setiap bulan sebagai dasar evaluasi efektivitas tindakan perbaikan yang telah dilakukan.

2.5 DATA INSIDEN KESELAMATAN PASIEN RS PRIMA HUSADA PERIODE BULAN JANUARI-MARET TAHUN 2026

No.	Tanggal	Kronologi	IKP	Grade	Tindak Lanjut
1.	06/01/2026	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada pasien maupun petugas	KPCS	Hijau	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu "lantai basah" - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
2.	08/01/2026	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada pasien maupun petugas	KPCS	Hijau	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu "lantai basah" - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
3.	14/01/2026	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada pasien maupun petugas	KPCS	Hijau	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu "lantai basah" - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
4.	19/01/2026	Anamnesis dan pemeriksaan fisik tidak sesuai	KTC	Hijau	Penguatan supervisi dokter IGD
5.	19/01/2026	Kesalahan input e-resep	KTC	Hijau	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
6.	19/01/2026	Terdapat tumpahan yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada pasien maupun petugas	KPCS	Hijau	- Sosialisasi pencegahan risiko jatuh - Penyediaan rambu "lantai basah" - Penegasan SOP kebersihan & respon cepat tumpahan
7.	26/01/2026	Kesalahan pemberian obat	KTC	Hijau	- Refresh SOP e-resep - Double check sebelum validasi resep - Edukasi keselamatan obat
8.	28/01/2026	Tidak melakukan advice dokter sesuai jam yang diadvicekan	KPCS	Hijau	- Penguatan komunikasi DPJP & perawat - Monitoring pelaksanaan advice - Edukasi patient safety
9.	02/02/2026	Kesalahan pemberian obat karena kesalahan order permintaan obat dan semua petugas farmasi tidak melakukan double check	KTC	Hijau	- Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum diserahkan pada pasien - Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket maupun KIE
10.	02/02/2026	Kesalahan pemberian obat karena obat pasien tertinggal (tidak diberikan pada pasien)	KTC	Hijau	- Melakukan pengecekan ulang pada saat packing resep dan sebelum diserahkan ke pasien - Peningkatan kedisiplinan penulisan paraf pada label ISEP sehingga dapat diketahui petugas yang melakukan input, penyiapan, etiket maupun KIE
11.	05/02/2026	Kesalahan input e-resep	KPCS	Hijau	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis

12.	05/02/2026	Kesalahan input e-resep	KNC	Hijau	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
13.	05/02/2026	Kesalahan input e-resep	KPCS	Hijau	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
14.	05/02/2026	Kejadian makanan basi	KTC	Hijau	- Melakukan QC secara keseluruhan terhadap makanan pasien - Tidak membuat bahan makanan setengah jadi jauh jauh hari - Selalu memberi label tanggal pembuatan makanan setengah jadi
15.	05/02/2026	Ditemukan tumpahan air yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada petugas maupun pasien	KPCS	Hijau	Segera memasang tanda risiko jatuh dan melaporkan kepada tim cleaning service
16.	06/02/2026	Ditemukan tumpahan air yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada petugas maupun pasien	KPCS	Hijau	Segera memasang tanda risiko jatuh dan melaporkan kepada tim cleaning service
17.	06/02/2026	Ditemukan tumpahan air kencing yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada petugas maupun pasien	KPCS	Hijau	Segera memasang tanda risiko jatuh dan melaporkan kepada tim cleaning service
18.	07/02/2026	Miskomunikasi terkait kondisi pasien dari FKTP sehingga pasien yang seharusnya dirawat oleh Dokter Bedah tidak dirawat oleh Dokter Bedah karena kondisi pasien saat dirujuk tidak menunjukkan kegawatan bedah sehingga pasien mengalami delay pelayanan.	KTD	Hijau	Pasien dirawat oleh dokter IPD
19.	10/02/2026	Kesalahan input e-resep	KPCS	Hijau	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
20.	10/02/2026	Ditemukan tumpahan air yang dapat menimbulkan risiko jatuh pada petugas maupun pasien	KPCS	Hijau	Segera memasang tanda risiko jatuh dan melaporkan kepada tim cleaning service
21.	27/02/2026	Kejadian pasien jatuh di ruangan karena pasien tidak di tunggu oleh keluarga dan keluarga tidak menitipkan kepada perawat, sehingga perawat tidak memindahkan pasien ke kamar yang dekat dengan NS	KTD	Kuning	Melakukan KIE pada keluarga untuk menjaga pasien dan melakukan edukasi terkait upaya pencegahan risiko jatuh
22.	28/02/2026	Pasien mendapat makan yang tidak sesuai advice karena permintaan belum di update oleh DPJP	KTC	Hijau	- Membaca ulang secara keseluruhan dari daftar diet yang di update - Fokus bekerja / tidak bermain hp di luar urusan pekerjaan
23.	01/03/2026	Kejadian makanan basi karena ahli gizi kurang teliti saat menginput update diet di komputer	KTC	Hijau	Peningkatan kedisiplinan staf untuk membaca ulang secara keseluruhan dari daftar diet yang sudah di update dan fokus saat bekerja.
24.	01/03/2026	Kesalahan input e-resep	KTC	Hijau	- Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis

					- Koordinasi dengan kepala bidang pelayanan medis dan kepala ruang poli untuk mengecek template resep agar dirubah dan tidak terjadi kesalahan berulang.
25.	02/03/2026	Kesalahan input e-resep	KPCS	Hijau	Koordinasi dengan komite medik dan kepala bidang pelayanan medis
26.	10/03/3036	Tidak tertulisnya pengkajian alergi obat dari IGD sehingga tidak teroper ke ruangan	KPCS	Hijau	Refreshing di IGD mengenai input di e-rm mengenai alergi obat
27.	24/03/2026	Pelaksanaan tindakan kristeller untuk membantu persalinan sehingga menyebabkan symphiolisis pubis	KTD	Hijau	- Audit maternitas - Pemahaman ada aturan dari dinkes tidak boleh kristeller - KIE tertulis dan ditandatangani kepada keluarga sebelum tindakan persalinan untuk semua pasien bersalin - Adfis DPJP tindakan kristeller untuk membantu persalinan - Inform consent jika dilakukan

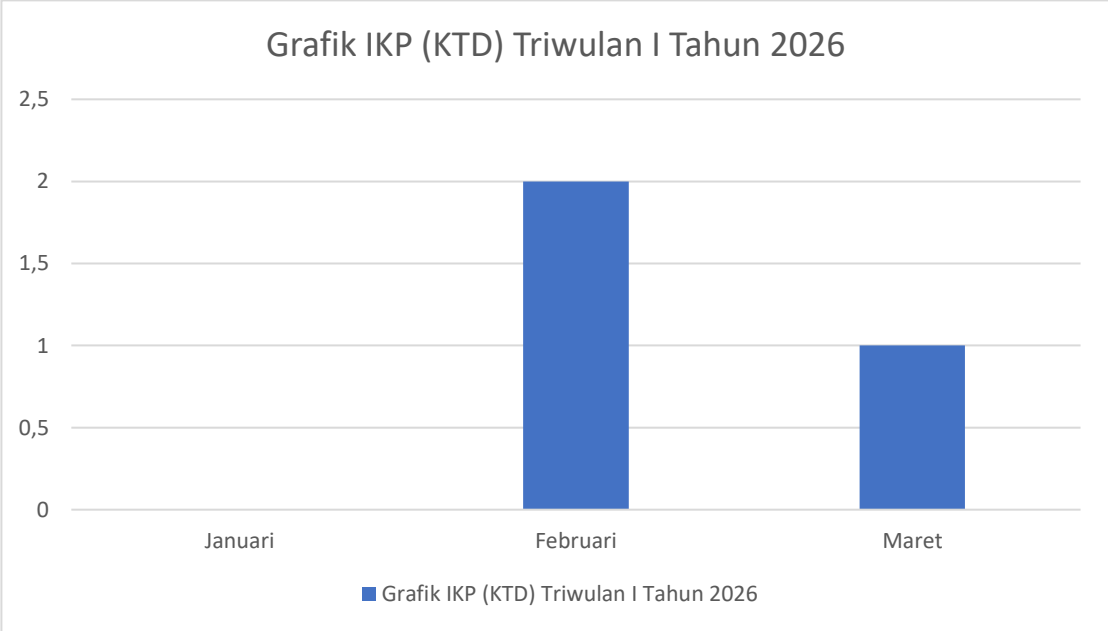
2.6 GRAFIK INSIDEN KESELAMATAN PASIEN TW I TAHUN 2026 RS PRIMA HUSADA MALANG

1. Sentinel



Analisis:
Berdasarkan data IKP Sentinel Triwulan I Tahun 2026, tidak terdapat kejadian sentinel di Rumah Sakit Prima Husada Malang selama periode Januari hingga Maret 2026. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya penerapan keselamatan pasien, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap standar pelayanan dan prosedur operasional yang berlaku telah berjalan dengan baik. Tidak adanya kejadian sentinel mengindikasikan bahwa tidak terjadi insiden yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit pasien. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian risiko di lingkungan rumah sakit. Meskipun demikian, kewaspadaan dan upaya peningkatan mutu pelayanan perlu terus dipertahankan melalui penguatan budaya keselamatan pasien, pelaporan insiden, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna mencegah terjadinya kejadian sentinel pada periode berikutnya.

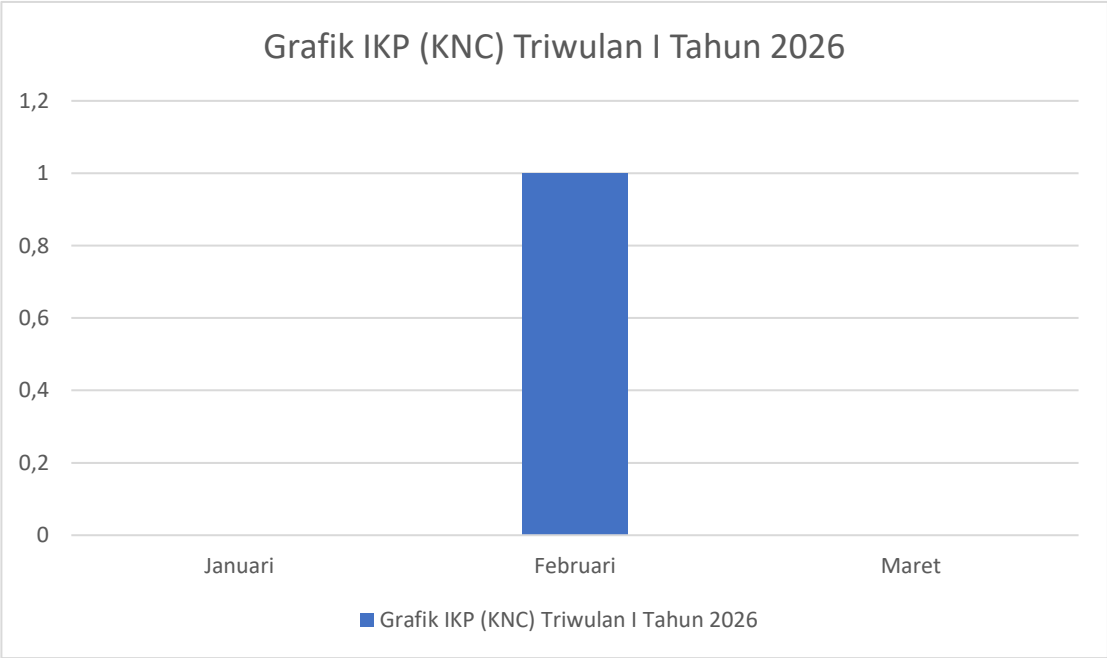
2. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)



Analisis:

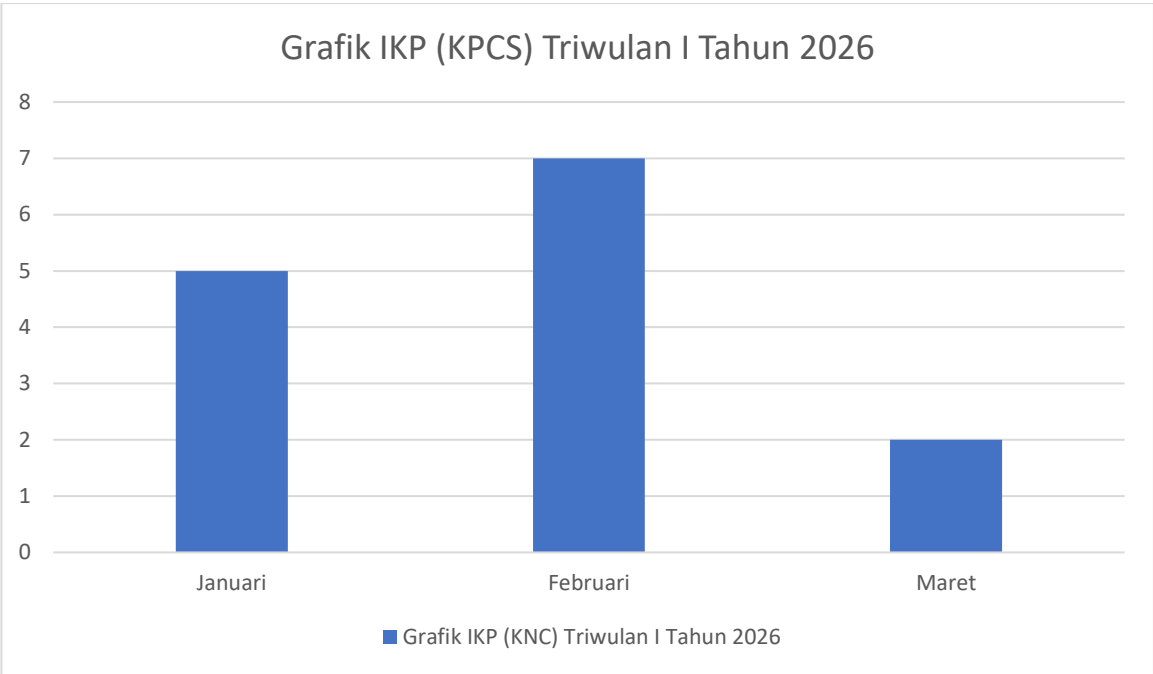
Berdasarkan grafik IKP KTD Triwulan I Tahun 2026, pada bulan Januari tidak terdapat kejadian tidak diharapkan (KTD). Namun, pada bulan Februari terjadi 2 insiden KTD yang terdiri dari 1 insiden dengan bands hijau dan 1 insiden dengan bands kuning. Salah satu insiden mengakibatkan keterlambatan pelayanan (*delay pelayanan*) kepada pasien, sedangkan insiden lainnya menyebabkan cedera pada pasien. Pada bulan Maret terdapat 1 insiden KTD dengan bands hijau. Munculnya kejadian KTD pada periode ini menunjukkan masih adanya risiko dalam proses pelayanan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap pasien, baik berupa keterlambatan pelayanan maupun cedera. Meskipun sebagian besar insiden berada pada kategori risiko rendah hingga sedang, kejadian tersebut tetap perlu menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Tindak lanjut yang telah dilakukan berupa penguatan edukasi kepada keluarga pasien terkait pencegahan risiko jatuh serta pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara tertulis yang ditandatangani oleh keluarga sebelum tindakan persalinan mengenai berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses persalinan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman keluarga, memperkuat keterlibatan pasien dan keluarga dalam proses perawatan, serta menurunkan risiko terjadinya insiden di masa mendatang.

3. Kejadian Nyaris Cedera (KNC)



Analisis:
Berdasarkan grafik IKP KNC Triwulan I Tahun 2026, pada bulan Januari dan Maret tidak terdapat kejadian nyaris cedera (KNC). Sementara itu, pada bulan Februari terdapat 1 kejadian KNC dengan kategori bands hijau, yaitu kesalahan input e-resep. Kejadian ini tidak sampai menimbulkan dampak kepada pasien karena berhasil teridentifikasi sebelum mencapai pasien, namun tetap menunjukkan adanya potensi risiko dalam proses peresepan elektronik. Insiden tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan ketelitian dan verifikasi dalam proses penginputan resep untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat berdampak pada keselamatan pasien. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan koordinasi dengan Komite Medik dan Kepala Bidang Pelayanan Medis untuk mengimbuai DPJP dan perawat agar lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan input e-resep. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur peresepan elektronik serta mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.

4. Kejadian Potensial Cedera Signifikan (KPCS)



Analisis:

Berdasarkan grafik IKP KPCS Triwulan I Tahun 2026, terdapat 5 insiden KPCS pada bulan Januari. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada bulan Februari menjadi 7 insiden, kemudian menurun pada bulan Maret menjadi 2 insiden. Fluktuasi jumlah insiden ini menunjukkan bahwa masih terdapat kondisi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera pada pasien, namun berhasil diidentifikasi dan dicegah sebelum menimbulkan dampak. Peningkatan jumlah KPCS pada bulan Februari dapat mencerminkan meningkatnya kewaspadaan petugas dalam mengidentifikasi dan melaporkan potensi risiko keselamatan pasien. Sementara itu, penurunan jumlah insiden pada bulan Maret dapat mengindikasikan adanya perbaikan dalam proses pelayanan atau efektivitas tindak lanjut yang telah dilakukan. Meskipun tidak sampai menimbulkan cedera pada pasien, kejadian KPCS tetap perlu menjadi perhatian karena menunjukkan adanya celah dalam sistem pelayanan yang berpotensi menyebabkan insiden apabila tidak segera diperbaiki. Oleh karena itu, upaya identifikasi risiko, pelaporan insiden, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mencegah terjadinya insiden yang lebih serius.

BAB III
PENUTUP

Demikian laporan Insiden Keselamatan pada Triwulan I Tahun 2026 di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Upaya yang dilakukan adalah upaya maksimal yang bisa dilakukan saat ini, terutama upaya angka kejadian KTD / KTC / KNC / KPCS dapat ditekan dan kejadian serupa tidak akan terulang Kembali, baik di tempat / unit yang sama maupun di tempat / unit yang lain di rumah sakit Prima Husada Malang, sehingga dapat meningkatkan Mutu dan Keselamatan Pasien dan lebih utama lagi terlaksananya asuhan pasien yang lebih aman.

Penyusun,
Ketua Komite PMKP



dr. Diah Puspita Rifasanti, Sp.M

Malang, 12 April 2026
Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes